Limpieza y mantenimiento rutinario del autoclave

Objetivo

Establecer una secuencia verificable para limpieza y mantenimiento rutinario del autoclave, articulada con la oferta y los recursos reales del consultorio.

Alcance y responsabilidades

Aplicación en odontologia ambulatoria, dentro de competencia y modalidad habilitada. Responsable clínico o del proceso: asignar en la adopción; personal de apoyo actúa según rol y entrenamiento. Confirmar aplicabilidad al prestador y sede antes de adoptar.

Términos de uso

Criterio: condición que se verifica. Evidencia: soporte auténtico de lo realizado. No conformidad: diferencia frente al criterio aplicable. Contención: medida inmediata para impedir daño. Cierre: corrección cuya eficacia se comprobó. Los términos clínicos/técnicos particulares se interpretan conforme a la guía o manual indicado.

Seguridad

Equipo frío/despresurizado y aislado como instruye fabricante; separar mantenimiento de operador y reparación técnica. No retirar válvulas o dispositivos de seguridad ni usar químicos incompatibles.

Rutina

Limpiar cámara, bandejas, junta, drenaje y depósitos solo por método/frecuencia del modelo. Verificar calidad/nivel de agua y cambio; no usar agua de grifo por sustitución si fabricante requiere otra. Registrar tareas y hallazgos.

Servicio técnico

Programar mantenimiento, sensores/calibración cuando aplica y calificación; conservar informe real, repuestos, competencia y pruebas. Tras cambio mayor revisar desempeño y BI requeridos antes de retornar.

Retiro

Ante corrosión, fuga, alarma o cierre inseguro, señalizar y suspender. No utilizar ciclos clínicos como prueba informal de reparación; liberar equipo mediante criterios definidos y evidencia.

Aplicación paso a paso y respuesta a desviaciones

Antes de ejecutar

Verificar identificación del dispositivo/equipo, clasificación, compatibilidad del fabricante y estado de mantenimiento. Determinar zona sucia o limpia y barreras requeridas. Confirmar suministro de agua, detergente, barreras e indicadores apropiados y capacidad para completar el flujo sin improvisación. Si instrucción o compatibilidad faltan, detener y escalar al responsable.

Durante la tarea

Mantener segregación y código rastreable. Registrar parámetros y resultados propios de la etapa: limpieza, secado, inspección, sello, programa o control. Una etapa correcta no compensa otra fallida. No introducir material sucio en área limpia, liberar sin revisión ni mezclar paquetes retenidos con disponibles.

Criterio de detención

Suciedad residual, daño, empaque húmedo/roto, ciclo incompleto, control no satisfactorio o trazabilidad perdida obligan a retener lo afectado y evaluar extensión. Identificar cuarentena, conservar evidencia, restringir equipo/proceso si procede y localizar cargas relacionadas; el instrumental no se usa para comprobar su condición.

Corrección y retorno

Determinar causa, etapa a la que debe retornar el material, necesidad de barrera nueva y pruebas técnicas. Registrar nueva carga/vínculo cuando reprocesa. Retorno de equipo tras falla mayor requiere soporte y controles aplicables; no basta encenderlo o obtener cambio de color.

Auditoría de trazabilidad

Seleccionar una carga real y recuperar programa, parámetros, controles, liberación, paquetes y pacientes cuando corresponde. Consultar también en sentido inverso. Evaluar registros legibles, archivo de resultados, control positivo BI, condiciones de almacenamiento y seguimiento de incidencias.

Frecuencia y puntos de control

Ejecutar en cada atención, tarea o cambio que active este proceso. Definir periodicidad de revisión por riesgo, oferta, fabricante y norma aplicable; registrar la programación local. La periodicidad local no se presenta como exigencia legal universal.

Registros relacionados

Usar los formatos individuales vinculados al código ODO-EST17 en el índice maestro. Asociar fecha, responsable, resultado y ubicación de evidencia. Las historias y consentimientos diligenciados se mantienen en expediente reservado; los soportes administrativos no deben exponer datos clínicos.

Verificación, fundamento y adopción

Indicador y método de evaluación

Indicador local propuesto: ejecuciones verificadas con pasos críticos completos / ejecuciones revisadas × 100. Definir periodo, muestra, fuente y meta según riesgo. Con denominador cero anotar no calculable. Registrar además oportunidad y gravedad de desviaciones; no interpretar ausencia de reporte como ausencia de daño.

Acciones correctivas

Describir hallazgo concreto, medida inmediata, causa, acción, responsable y plazo. Verificar eficacia con evidencia posterior antes de cerrar. Si existe riesgo activo o falta competencia/recurso, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa segura.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Residuos

Resolución 591 de 2024, manual de gestión de residuos generados en atención en salud; Decreto 780 de 2016. Diagnóstico, ruta y soportes reales por sede.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No%20591%20de%202024.pdf

Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609

Reprocesamiento

Resolución 2183 de 2004 y criterios vigentes de habilitación; Resolución 914 de 2025 y manual DMER: vigencia general prevista 03/01/2027 conforme al artículo 15. Revisar transitoriedad del artículo 12 y reglas específicas del tipo de prestador.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_0914_2025.htm

Fuentes técnicas particulares

Consultar versión íntegra y vigente, población y metodología; adaptar con trazabilidad. Una referencia técnica orienta práctica y no es legislación colombiana.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2183-de-2004.pdf ;
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/manual-practicas-reprocesamiento-dmer.pdf ;
https://www.cdc.gov/dental-infection-control/hcp/dental-ipc-faqs/sterilization-monitoring.html ;
https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_0914_2025.htm

Soportes auténticos que deben anexarse

Adjuntar documentos de autoridad, títulos/licencias, guías completas, instrucciones del fabricante, contratos o registros reales que correspondan al contenido. No se producen certificados, mantenimientos, planos técnicos ni evidencias de ejecución ficticias.

Adopción y actualización

Completar responsables, recursos, límites y registros; aprobar con autenticación válida y capacitar antes de utilizar. Revisar ante cambio normativo, incidente, tecnología o población. El encabezado permanece vacío para personalización; el contenido es propuesta y no acredita por sí mismo cumplimiento.